Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 1 · avril 2026
p. 7–10 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ARTICLE THÉORIQUE

Le sens de la vie comme facteur transdiagnostique

Clarifications conceptuelles, modèles théoriques et questions ouvertes

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford et Sora Pazer
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

Les approches transdiagnostiques étudient les caractéristiques et processus psychologiques qui contribuent à l'apparition et au maintien de difficultés psychologiques à travers les catégories diagnostiques. Cet article théorique examine si, et en quel sens, le sens de la vie peut être conceptualisé comme un facteur transdiagnostique. En s'appuyant sur des critères discutés dans la littérature transdiagnostique, l'article clarifie d'abord le concept de sens de la vie, en distinguant entre présence de sens et recherche de sens ainsi qu'entre les composantes de cohérence, de but et d'importance. Trois modèles sont ensuite mis en regard : le sens de la vie comme facteur de vulnérabilité ou de protection, comme résultat d'une élaboration de sens réussie après des événements stressants et comme expression de structures motivationnelles englobantes. Il est soutenu qu'un manque de sens vécu devrait être compris moins comme un mécanisme distinct que comme un point nodal où convergent des processus motivationnels, cognitifs et émotionnels. Enfin, les implications pour l'évaluation et la psychothérapie sont discutées, et les exigences méthodologiques d'une mise à l'épreuve empirique du statut transdiagnostique du sens de la vie sont esquissées, en particulier les plans longitudinaux, la séparation de construits conceptuellement proches et l'attention portée à la variabilité culturelle.

Mots-clés : sens de la vie · approche transdiagnostique · psychopathologie · élaboration de sens · facteurs de protection

ABSTRACT

Transdiagnostic approaches investigate psychological characteristics and processes that contribute to the onset and maintenance of psychological problems across diagnostic categories. This theoretical paper examines whether, and in what sense, meaning in life can be conceptualized as a transdiagnostic factor. Drawing on criteria discussed in the transdiagnostic literature, the paper first clarifies the concept of meaning in life, distinguishing between presence of meaning and search for meaning as well as between the components of coherence, purpose, and significance. Three models are then contrasted: meaning in life as a vulnerability or protective factor, as an outcome of successful meaning making after stressful events, and as an expression of overarching motivational structures. It is argued that a lack of experienced meaning should be understood less as a distinct mechanism than as a nodal point at which motivational, cognitive, and emotional processes converge. Finally, implications for assessment and psychotherapy are discussed, and methodological requirements for an empirical test of the transdiagnostic status of meaning in life are outlined, in particular longitudinal designs, the separation of conceptually overlapping constructs, and attention to cultural variability.

Keywords: meaning in life · transdiagnostic approach · psychopathology · meaning making · protective factors

1 Introduction

La classification catégorielle des troubles mentaux s'est révélée indispensable pour la communication, les soins et la recherche. Ses limites sont toutefois connues depuis longtemps : des taux de comorbidité élevés, des frontières floues entre les diagnostics et le constat que des processus psychologiques similaires sont à l'œuvre dans différents troubles ont conduit à une perspective transdiagnostique. Dans une monographie influente, Harvey et al. (2004) ont montré que des processus tels que l'attention sélective, la pensée négative répétitive ou les comportements d'évitement se retrouvent dans de nombreux troubles. Sur le plan structurel, on a également discuté de la possibilité d'identifier un facteur général de psychopathologie (Caspi et al., 2014).

Dans ce contexte, il est naturel de se demander si le sens de la vie – ou son absence – peut lui aussi être compris comme un facteur transdiagnostique. La

logothérapie a, dans une certaine mesure, anticipé une telle hypothèse en décrivant la frustration de la volonté de sens comme un état susceptible de se manifester par différents symptômes (Frankl, 1969). La présente contribution examine cette intuition à la lumière des critères théoriques actuels. Elle se veut une analyse conceptuelle et non une synthèse de données empiriques originales.

2 Critères des construits transdiagnostiques

Nolen-Hoeksema et Watkins (2011) ont proposé une heuristique permettant de spécifier les modèles transdiagnostiques. Ils distinguent les facteurs de risque distaux qui accroissent la vulnérabilité, les processus proximaux directement impliqués dans la formation des symptômes et les conditions modératrices qui expliquent pourquoi un facteur commun conduit à des troubles différents chez des individus différents. Dès lors, un construit ne mérite pas le qualificatif de « transdiagnostique » du seul fait qu'il est corrélé à plusieurs troubles. Ce qui est requis, c'est plutôt un modèle théoriquement fondé de la manière dont il influe sur le développement et le maintien des symptômes.

Pour le sens de la vie, il en découle une double tâche. Il faut d'abord clarifier ce que l'on entend exactement par sens de la vie. Il faut ensuite déterminer à quel niveau du modèle – comme facteur distal, comme processus proximal ou comme modérateur – il convient de le situer. Ces deux questions ne sont pas toujours suffisamment distinguées dans la littérature.

3 Spécification conceptuelle

Avec la distinction entre présence de sens et recherche de sens, Steger et al. (2006) ont introduit une différenciation aux conséquences considérables pour la recherche empirique. Alors que la présence de sens vécue est généralement associée au bien-être, la relation entre la recherche de sens et la santé mentale est plus complexe et apparemment dépendante du contexte. Martela et Steger (2016) ont en outre distingué trois facettes de l'expérience du sens : la cohérence, au sens de l'intelligibilité de sa propre vie ; le but, au sens d'une orientation motivante vers des objectifs valorisés ; et l'importance, au sens du vécu de sa propre vie comme précieuse et comptant pour quelque chose.

Schnell (2009) a également montré qu'il convient de distinguer les sources dont les personnes tirent du sens de l'expérience globale du sens. Cette distinction est cliniquement significative : un manque de sens vécu peut tenir à la perte de sources de sens particulières, à une faible diversité de ces sources ou à un défaut d'intégration dans une compréhension de soi englobante. Par ailleurs, Schnell (2020) a attiré l'attention sur l'état d'« indifférence existentielle », dans lequel le sens n'est ni vécu ni recherché – un état qui se distingue nettement d'une crise de sens aiguë.

Pour la question transdiagnostique, il s'ensuit que le « sens de la vie » n'est pas un construit unitaire. Quiconque parle du sens comme d'un facteur transdiagnostique doit préciser de quelle facette il s'agit, puisque la cohérence, le but et l'importance sont potentiellement liés à des processus psychopathologiques différents.

En outre, l'expérience du sens et la recherche de sens ne doivent pas être comprises comme les pôles opposés d'une seule dimension (Steger et al., 2006). Une personne peut vivre sa vie comme pleine de sens et rechercher en même temps un sens plus profond ; à l'inverse, quelqu'un peut éprouver peu de sens sans le rechercher activement. Ces configurations ont vraisemblablement une signification clinique différente, dont il faut tenir compte dans la formulation d'hypothèses transdiagnostiques.

4 Trois conceptions de modèle

Un premier modèle comprend le sens vécu comme un facteur de protection et son absence comme un facteur de vulnérabilité. Cette conception s'apparente aux réflexions salutogéniques telles que les a formulées Antonovsky (1987) avec le concept de sentiment de cohérence, dans lequel la signifiance occupe une position centrale en tant que composante motivationnelle. Dans ce modèle, le sens de la vie serait un facteur distal au sens de Nolen-Hoeksema et Watkins (2011), qui influence la probabilité de divers troubles sans en déterminer la forme spécifique.

Un deuxième modèle met l'accent sur la dimension processuelle. Dans son modèle d'élaboration de sens (meaning making), Park (2010) décrit comment des événements stressants créent un écart entre les structures globales de sens et l'évaluation situationnelle d'un événement, écart qui peut être réduit par des processus d'élaboration de sens. Dans ce cadre, les difficultés psychologiques pourraient être comprises comme l'expression d'une élaboration de sens non réussie. Le sens n'y est pas d'abord un trait stable, mais le résultat d'un traitement continu susceptible d'être impliqué de manière proximale dans le maintien des symptômes.

Enfin, un troisième modèle interprète l'expérience du sens comme l'expression de structures

motivationnelles englobantes. Baumeister (1991) a décrit des besoins de sens portant sur le but, les valeurs, l'efficacité et l'estime de soi. Dans cette perspective, un manque de sens renvoie à une perturbation de l'orientation motivationnelle, qui peut se manifester par exemple par une baisse de l'élan, des comportements d'évitement ou des stratégies compensatoires. Yalom (1980) a lui aussi décrit l'absence de sens comme l'une des préoccupations ultimes de l'existence, que les personnes affrontent de manières très diverses, parfois dysfonctionnelles.

La logothérapie ne peut être clairement rattachée à aucun de ces modèles. Le concept franklien de névrose noogène décrit des troubles qui naissent principalement d'un conflit existentiel ou d'une frustration existentielle (Frankl, 1969). Il postule ainsi une étiologie spécifique censée se distinguer des troubles psychogènes et somatogènes. En même temps, Frankl souligne qu'un vide existentiel peut aussi exister sans signification pathologique et se manifester sous différentes formes. D'un point de vue transdiagnostique, cette double fonction est remarquable, car elle conceptualise la frustration du sens à la fois comme une cause spécifique et comme un facteur d'arrière-plan non spécifique.

5 Le sens comme point nodal : une interprétation intégrative

Les trois modèles ne s'excluent pas mutuellement. Bien des éléments plaident pour comprendre un manque de sens vécu moins comme un mécanisme autonome et isolable que comme un point nodal où convergent des processus motivationnels, cognitifs et émotionnels. Les résultats selon lesquels l'affect positif influence l'expérience momentanée du sens (King et al., 2006) illustrent que l'expérience du sens n'est pas indépendante de l'état affectif d'une personne. À l'inverse, il est plausible qu'une orientation stable vers des valeurs puisse amortir des crises affectives.

Une telle interprétation en termes de point nodal a des conséquences pour la recherche. Elle met en garde contre le fait de traiter l'expérience du sens comme un simple reflet des symptômes dépressifs, aussi bien que contre celui de l'ériger en principe explicatif universel. Heintzelman et King (2014) ont d'ailleurs souligné que la plupart des personnes décrivent leur vie comme assez riche de sens. Un manque de sens cliniquement pertinent constitue donc l'exception plutôt que la règle, ce qui importe pour la détermination de seuils et de groupes à risque.

Un autre aspect concerne la direction des associations. Les corrélations transversales entre une faible expérience du sens et des difficultés psychologiques sont compatibles avec plusieurs hypothèses causales : un manque de sens peut favoriser les difficultés, les difficultés peuvent altérer l'expérience du sens, ou les deux peuvent tenir à des facteurs tiers communs. Un modèle transdiagnostique doit distinguer explicitement ces possibilités et ne doit pas inférer prématurément des directions d'effet à partir d'associations.

6 Implications et questions ouvertes

Pour l'évaluation diagnostique, l'analyse suggère d'évaluer l'expérience du sens de manière spécifique à chaque facette et indépendamment des troubles, plutôt que de la relever simplement comme variable concomitante. Pour la psychothérapie se pose la question de savoir si des interventions centrées sur le sens peuvent être utilisées comme modules complémentaires dans différents contextes de traitement. Cela correspondrait à la conception que Frankl avait de la logothérapie comme complément d'autres procédures.

Une mise à l'épreuve empirique du statut transdiagnostique du sens de la vie exigerait en particulier des plans longitudinaux saisissant les successions temporelles entre l'expérience du sens et l'évolution des symptômes, une séparation soigneuse de construits conceptuellement proches tels que le désespoir, le bien-être ou l'auto-efficacité, ainsi que la prise en compte de la variabilité culturelle de la signification du sens. Tant que ces exigences ne sont pas satisfaites, l'idée du sens de la vie comme facteur transdiagnostique doit être comprise comme une hypothèse heuristiquement féconde, et non comme un résultat établi.

Pour la pratique thérapeutique, il faut en outre garder à l'esprit qu'aborder la question du sens n'est pas indiqué à n'importe quel moment d'un traitement. En cas de crise aiguë, de symptômes dépressifs sévères ou de baisse marquée de l'élan, la question explicite du sens de sa propre vie peut être accablante ou renforcer des sentiments d'échec. Une compréhension transdiagnostique du sens ne plaide donc pas pour une application indifférenciée des techniques centrées sur le sens, mais pour une détermination soigneuse de l'indication, qui tienne compte de l'état de la personne, de ses ressources et du déroulement du traitement.

Références

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. Jossey-Bass.

Baumeister, R. F. (1991). Meanings of life. Guilford Press.

Caspi, A., Houts, R. M., Belsky, D. W., Goldman-Mellor, S. J., Harrington, H., Israel, S., Meier, M. H., Ramrakha, S., Shalev, I., Poulton, R., & Moffitt, T. E. (2014). The p factor: One general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders? Clinical Psychological Science, 2(2), 119–137.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Harvey, A. G., Watkins, E., Mansell, W., & Shafran, R. (2004). Cognitive behavioural processes across psychological disorders: A transdiagnostic approach to research and treatment. Oxford University Press.

Heintzelman, S. J., & King, L. A. (2014). Life is pretty meaningful. American Psychologist, 69(6), 561–574.

King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J. L., & Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life. Journal of Personality and Social Psychology, 90(1), 179–196.

Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 531–545.

Nolen-Hoeksema, S., & Watkins, E. R. (2011). A heuristic for developing transdiagnostic models of psychopathology: Explaining multifinality and divergent trajectories. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 589–609.

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301.

Schnell, T. (2009). The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe): Relations to demographics and well-being. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 483–499.

Schnell, T. (2020). Psychologie des Lebenssinns (2. Aufl.). Springer.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Whitcombe, E. M., Ashford, S. R., & Pazer, S. (2026). Meaning in Life as a Transdiagnostic Factor: Conceptual Clarifications, Theoretical Models, and Open Questions. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 7–10.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.